

On va voir que finalement le développement du cerveau, dans cette dynamique, ça va orienter et organiser tous ces phénomènes de membranes intracrâniennes et qui va soutenir et permettre de créer ce système de membranes de tension réciproque dans lequel va parcourir tous les vaisseaux, en tout cas des vaisseaux importants sur le plan veineux pour drainer et libérer ce CO₂, ces choses qui doivent repartir d'une façon bien spécifique et que pas mal de problèmes viennent en fait de stases avec des points clés qu'on va étudier, entre autres au niveau de certains confluentiels tels que les ptéridiens ou les certains sinus veineux transversaux sur le plan occipital. On a des réunions de presque de huit feuillets qui vont se faire à ce niveau-là. Tu vois, c'est vraiment une rencontre, un carrefour important. Et aussi la base du crâne. On peut dire que ce mécanisme crâne sacré, il est important dans le sens que c'est lui, c'est une de nos références sur lesquelles on peut toujours s'appuyer. Est-ce que j'ai un bon mécanisme crânien ? Crânien sterno-sacrés, crâniens sterno-sacrés mandibulaires à partir d'un âge où l'enfant se redresse. Au moment où l'enfant commence à avoir ses dents, l'enfant commence à se redresser. Les dents, c'est des capteurs de posture. Vous allez comprendre quelque chose maintenant dans votre tête, ça va vous faire timbre avec ce que je vais vous dire. L'importance que les dents, c'est des appuis pour ta posture. C'est vraiment des appuis pour que tu puisses respirer correctement en fait. C'est vraiment bizarre. La langue est très importante aussi. Au départ, on cherche, vous voyez des enfants, ils sont comme ça là. Il cherche la langue, c'est très important. Après les dents arrivent et quand il commence à avoir des points de support avec les dents au-dessus et en-dessous, l'enfant se redresse. Et maintenant là vous allez comprendre, regardez avant les vieillards, quand ils n'avaient plus de dents, comment ils étaient les vieux. Merci. Elle est tombée dedans, elle est tombée dedans.

Sous-titrage ST' 501 Tu leur mets maintenant des dents, ils se

redressent. Tous ces gens, tous ces personnes âgées ont des dents, ont des dentiers. Ils ont des points d'appui pour respirer. Tu demandes à un petit vieux qui n'a plus de dents, tu lui dis, allez, redresse-toi. Il ne sait pas respirer. Il ne sait plus sourire. Il cherche des points d'appui pour sa respiration avec sa posture. Donc les dents deviennent des capteurs de redressement de l'enfant et de redressement de ta posture. C'est très important. C'est très important aussi de ne pas avoir une dent qui manque sur un côté. Tu as une dent, tu l'enlèves, tu en as une sur le côté qui est enlevée. Pourquoi ? C'est très important. Si tu as une dent qui manque, ta langue, ce qu'elle fait, elle se déplace sur le côté. Donc elle vient légèrement ouvrir son espace, ta langue, parce qu'elle est super, la langue c'est magnifique pour plein de choses. Elle dépasse sur le côté, ici, là, elle vient boucher le trou. Pour faire ta déglutition. Et en fait, comme la langue fait partie de l'axe lingual, fait partie de ton axe longitudinal, ce qu'on appelle l'axe de la chaîne embryonnaire, ça c'est le premier axe, c'est ta chaîne embryonnaire qui se termine au niveau de tes pouces et de tes gros orteils, c'est ta chaîne embryonnaire qui s'organise comme ça. Et donc tu vas chercher par ta langue, par ta posture, par tes dents, à maintenir ton équilibre. Et l'œil, finalement... Il va chercher sa stabilité par rapport à ton système vestibulaire, avec une orientation de 23 degrés comme ça, une orientation de 23 degrés comme ça, au niveau du cœur. Au départ, l'oreille interne est orientée comme ça, comme ceci. Et puis, par la croissance, tu viens rechercher ici. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de titres avant, les enfants. Surtout si l'enfant, on crie trop à la maison. Observez, les enfants qui ont des otites, c'est des enfants, ça gueule à la maison. Voilà, la première chose que je dis, vous allez un peu vous calmer madame, non je rigole. Non mais je dis, on va parler peut-être un peu moins fort, il se protège. Il y a une protection de l'eau qu'on va mettre. Et puis en même temps, il cherche à horizontaliser à un moment. Quand il se

redresse, qu'il s'horizontalise, il atteint une angulation. Qui est une angulation qui va retrouver la même angulation au niveau du cœur, la même angulation que l'inclinaison de la tête. Maman Tu t'orientes par rapport à ton univers sur tes plans angulatoires. Tu recherches la stabilité. Le corps, il est toujours un peu en avant aussi. Si tu regardes, il y a toujours un certain degré où il est comme ceci. En fait, si tu regardes quelqu'un, tu vas voir par rapport à son axe, il a une bascule tendance comme ceci. Tu avales jusqu'à 1 ou 2 litres par jour. Tu fais 25 000 respirations par jour. Ton cœur va 100 000 fois par jour. Ça, c'est un rythme digestif. Ça, c'est un rythme respiratoire. Ça, c'est un rythme cardiaque. En fait, ce qu'on va faire, c'est se positionner dans nos différents rythmes. Rythme cardiaque, mon rythme digestif qui est très important. Les dents, c'est vraiment très important. C'est en rapport aussi avec l'audition. Parce que les diverticules, ça, ce sera la prochaine fois. Tu as le cartilage de McKay qui se continue avec l'oreille interne. Tu as l'apophyste hyloïde qui se continue avec le système de l'oreille interne. Je te laisse en détail la prochaine fois. On va voir comment on peut ramener ça dans sa ligne médiane et comment on peut redégager le système. Ça se fait comme ça. C'est de l'embryo. C'est l'étude de la face. Déjà, ces deux os magiques, le sphénoïde et l'occipute, Déjà, c'est deux os magiques. on va voir qu'ils sont soumis. complètement à ce mécanisme crâne sacré, tu vois. C'est schématique, mais ça nous montre quand même, tu vois, regardez ce qui va se passer simplement dans une flexion et une extension au niveau des dents. Regardez, il y a des gens qui usent complètement la partie antérieure, des gens qui usent complètement la partie postérieure. C'est vraiment important de comprendre ce schéma. Et puis on va voir que vous avez la chaîne occipito-linguale qui est vraiment une chaîne très importante pour la dynamique complète du corps. C'est une ligne médiane, ça fait partie presque indirectement d'une continuité de cette note au corps. C'est une représentation qui

n'est pas anatomique, mais c'est vraiment un point d'appui. Tout ce complexe lingual et la langue, c'est le bourgeon du cœur. La langue va donner vis-à-vis du foramen séqué, la thyroïde. La thyroïde, elle va électrifier vos mots. vous allez devoir parler avec vos sinus frontaux, c'est-à-dire qu'il faudra faire front. C'est à ce moment-là, des gens qui font trop front, ou des gens qui ne font pas assez, c'est une question de gorge. Si tes mots sont... C'est pour ça qu'à un moment donné, on n'a plus besoin de donner des mots. On parle complètement en fréquence. Il y a des gens, ils donnent juste des fréquences, comme ça, par exemple, les mantras, ça devient des fréquences, ça devient des sons archétypes qui re-neutralisent et te ramènent dans un archétype conscient, de l'inconscient collectif, donc qui re-neutralisent les mots. Les mantras sont faits pour arrêter ton discours intérieur incessant. Le chien. occipitaux, linguailles. Regardez la puissance de cette chaîne. Elle interfère ici, c'est la chaîne linguaille. Puis vous allez avoir la chaîne qui est la chaîne ici, normalement sphénoïda et laxienne ici. C'est une chaîne d'anticipation de votre vie. Ça c'est une chaîne descendante ici. On en reparlera la prochaine fois dans le viscérotrage. Très bien. Et pour vous montrer finalement tout ce plan mécanique, si on peut dire, de ces différentes chaînes, où on voit l'action globale de toutes ces lignes de force qui sont présentes et qui sont des signes, des suites descendantes. On a le viscérocrane et on a le neurocrane. On voit qu'entre les deux, on a cette base du crâne. Et cette base du crâne est un élément très important pour le développement et elle est liée, en fait, à la base du crâne. C'est une articulation entre les aores et le cerveau. Déjà le crâne se dessine ici, il commence déjà, on a déjà presque une image future. C'est le unlike, c'est l'image précurseur pour le crâne. Avec déjà le cerveau qui lui va vraiment avoir son importance C'est lui qui dynamise le système avec une vitesse de croissance différentielle C'est... qui va amener, tu vois, cette flexion de

l'embryon avec le processus du téléencéphale, du diéleencéphale qui vient du prosencéphale, le mésencéphale, et puis derrière, on a le rhombocéphale qui va donner cette dynamique avec le méthane et le truc en dessous du cerveau. C'est une articulation entre le cerveau et l'aore. Alors, à un moment donné, on voit qu'il y a une flexion. Et dans cette flexion, qui va s'organiser ici, voilà la clé, par la suite du recourbement de l'embryon, c'est-à-dire de cette flexion de l'encéphale vers l'avant, le mésenchyme qui est sous le mésencéphale devient perpendiculaire par rapport à l'axe longitudinal de l'embryon. Tu vois ? Il y a une compression ici. Cette orientation sous-mésencéphalique mène à un développement qu'on appelle le septum sous-mésencéphalique qui est relié entre l'avant et l'arrière du cerveau. Donc tu vois, ça se comprime ici. Et c'est le cœur, avec ses aortes, et la cavité amniotique qui organisent cet espace. Le septum. qui se développe ici, tu vois, qui devient la base du crâne. Et c'est là qu'on voit, à un moment donné, dans cette flexion, si maintenant je fais une marche arrière, il y a une petite poche ici, tu vois, c'est une petite poche endodermique. C'est un tissu, ici, de tissu noir, c'est de l'intestin. Donc c'est de l'endoderme. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça va devenir cette petite poche. Vous savez comment ça s'appelle, cette petite poche ? Ça s'appelle la poche de Ractée. Vous voyez, avec ici derrière, la poche de Cécène, enfin bon, la poche de Ractée. Et cette poche de Ractée, ça va devenir, au niveau de la base du crâne, une des structures les plus importantes qu'on appelle l'hypophyse antérieure. Je vous rappelle que l'hypophyse, elle est faite de deux parties. D'une partie neurologique et d'une partie digestive. Eh bien, cette partie-là, cette réunion des deux, va former l'hypophyse. Et au départ, vous avez... cette poche, qu'on appelle la poche de Ractée, qui vient... Si maintenant on fait l'inverse, tu vois, et j'ouvre et je diminue la taille, je remets l'embryon dans sa phase initiale avant, cette poche qui est comme ça, tu vois, et je prends juste cette petite poche, ici,

comme ça, tu la vois, hein ? Et j'ouvre, ça fait ça. Elle redevient plate. Et en fait, c'est la flexion de l'embryon avec le frein du cœur, qui amène, à un moment donné, à faire ce pli, comme un champ d'aspiration du tissu, tu vois, un champ de succion, comme on a vu, qui prend, et qui absorbe, et qui vient se mettre au niveau de cette base du crâne, dans sa partie antérieure. Et ça va former ce qu'on appelle l'antéhypophyse. Au même moment, vous avez une partie postérieure qui vient, qui est l'infundibulum, qui vient de la partie supérieure au niveau du cerveau, même champ d'aspiration, et qui vient de se rencontrer pour faire l'hypophyse. C'est l'hypophyse neurologique. Et les deux ensemble font l'hypophyse, avec tout ce chef d'orchestre, parce que c'est vraiment... Et on envoie des hormones, et on envoie des trucs, et on fait le bazar, etc. C'est un chef d'orchestre neurologique, endocrinien, énorme ! Et où est-ce que ça se dépose, le chef d'orchestre ? Sur la base du crâne, qui est quoi ? Un point d'appui. Donc vous avez déjà un développement sur cette base du crâne, qui est à la fois purement endodermique, digestif, et en même temps neurologique. Ça veut dire que cette base du crâne connaît l'environnement du cerveau et l'environnement de votre système digestif. C'est un équilibre entre ton cerveau et ton système digestif. C'est un équilibre entre le neurocrâne et le viscérocrâne. Et c'est là où on voit trop de flexion, trop d'extension, cette ouverture, ce mouvement de la base du crâne, où que tu as ces phénomènes de torsion, mais tout ça, ça va se répercuter sur le fonctionnement, petit à petit, de cette fonction hypophysaire. La fonction a besoin de mouvement. La fonction, ce n'est qu'une répétition d'un mouvement primaire embryologique, à un moment donné. C'est pour ça que la vraie fonction, c'est un mouvement de motilité qui organisera un mouvement de mobilité, qui organisera un mouvement de motricité. Donc cette base du crâne, non seulement c'est une articulation au départ entre mon cerveau qui grandit et mes aortes qui freinent, Tout

le mécanisme, une des premières choses qui va se passer, c'est, hop, j'ai une petite poche qui se crée, qu'on appelle la poche de Ract, qui va créer la partie de l'hypophyse, ici, et en même temps, c'est un champ de contusion sur un plan métabolique, tu vois, comme on avait vu ce matin, puisque c'est deux tissus qui se contractent complètement à un champ qui était tout à fait derrière, tu vois, avec un champ, on avait vu les champs de détraction, on avait vu les champs comme ça, mais au départ, c'est un tissu cartilagineux jaune qui se développe là, sur un axe, et ça va développer ce qu'on appelle le cartilage hypophysaire, le cartilage paracordal, et le cartilage précordal en avant, qui vont être les précurseurs sur des plans, des nœuds cartilagineux, pour, dans l'espace, créer ta base hypoxépitale, ton sphénoïde et ton hétmoïde, et plus tard, on va voir dans une partie de tes pyramides pétreuses, et plus tard, on va voir comment, là-dedans, dans ce mouvement développemental, cette fois-ci, du cerveau, dans sa phase de cérébralisation, que tout le processus du frontal, du pariétal, de l'occiput, partie supérieure, jusque pour terminer la phase de tes temporaux, c'est une succession. Je prends ici, ça retourne, et on fait comme ça, hop, et là, ok, puis ça avance, et ça va devenir, tu vois, cartilage hypophysaire. Ça avance et ça va devenir... Ok, on regarde la couleur de la corde du sphénoïde. cartilage paracordal à côté de ma notochorte ok pas de problème qu'est-ce que c'est partie basilelle occipitale ah ma notochorte elle est ici ah oui elle monte là elle est entre quoi hein elle est entre quoi C'est juste une réponse. Et qu'est-ce qui vient se déposer dessus ? Quoi ? Mon hypofys. Ça, c'est le plan glandulaire. Donc j'ai déjà une compression cartilagineuse, et en plus, j'ai un plan glandulaire, et qui est complètement dépendant de tout ce qui se passe. Parce que ce point-là, c'est un point, en fait, on appelle ça le point zéro. Admettons qu'il y ait une tension sur la membrane. Je sais tout ce qui se passe. Et en dessous, je sens l'autre qui fait des bouboues, comme ça, derrière.

Je sens mon hypofys, je sens le système digestif, C'est juste... moi, j'ai mon système nerveux. Ça, c'est des membranes de tension qui sont en équilibre. Là, il y a un déficit au niveau sanguin. Je vois comme ça, voilà, ça va. comme ça, je suis, je sens tout ce qui se passe, toi tu bouges, recule juste ta jambe en arrière, je le sens, toi tu bouges ton bras vers le haut, l'autre bras, je le sens, toi tu descends ta tête, je le sens, je ressens tout ce que tu ressens, l'hypophyse et c'est tout ce qui se passe, sur un plan glandulaire, sur un plan osseux, cartilagineux, et on va voir quel que n'est tout sur un plan membre. Le foramen magnum, ici, avec ce qu'on appelle la cristagale, la plaque craniiformis. Là, on voit le cartilage de Meckel, avec les zones ici. Le méa acoustique, le foramen yugulaire qui est à côté. Regardez ici, quand on cherche parfois des clés entre le foramen yugulaire de la jugulaire et le méa acoustique, c'est une clé que je vous donne ici. La faussaire, il y a aussi la cellule turcotte qui est là. C'est ça qui est intéressant. Regardez bien cette jonction-ci, et puis avec la bouche et la mâchoire. C'est les acouphènes. Sous-titrage Société Radio-Canada Fasci-ménage, leptoménage. Reprenons ça au début. Vous vous souvenez de la formation du tube neural ? Maintenant, on va rajouter un élément. Le tube neural qui commence à se former. Notre corde. Qu'est-ce que j'ai ici autour, qui s'organise là ? J'ai quoi ? Une carotide. Tu vois les artères ? Ah bon ça ? Le début des artères carotides. Je l'ai. Oui, quelque part. Mais ça fait partie de quoi, ces carotides ? Ça, ça fait partie de quoi ? Et donc ici, il y a encore plein de méso, là. Et vous savez ce qui se passe ici dans ce mouvement ? Eh bien le méso qui est en dessous ici, il subit un champ métabolique ici, de rétention. Au départ il est un peu là comme ça, mais on est comme à un stade, parce que ce soit un champ de dilation ou un champ de rétention, ça va aussi dépendre en fonction de l'espace et du temps dans lequel on se trouve. Et là on a un stade où le tissu qui est ici, tu vois, le tissu qui est ici, eh bien il va subir un champ où il va recevoir

comme un stress, comme ça, tu vois, par le tissu qu'on voit ici, tu vois, là, hop, ça commence là, ici, et puis on voit ici, tu vois, ça commence à former un ectoménage. C'est l'ébauche, si tu veux, de la durmère. Tu la regardes ici, non seulement elle est ici, mais elle est ici aussi. Tout le long. C'est comme ici, tu vois, ça se développe tout le long, et ici c'est des coupes juste transversales, et si je fais une coupe transverso-sagittale, ça fait tout le long, comme la crête neurale, tout le long. Ok ? Donc je vois ici un champ qu'on appelle l'ectoménage, qui est en fait l'ébauche. C'est lié à la vitesse de croissance différentielle avec le rapport que j'ai par rapport à ma note de corps. qui va former mon tube neural, et le tube neural Oh mais mon... neural, et bien il va être emballé sur tout son axe déjà par un tissu, par une enveloppe qui vient l'entourer et qui vient dans un premier temps se fermer pour la première fois comme on a vu au niveau de la partie crânienne basse, là ici là-haut, et puis ça va former toute la longueur comme ceci pour se fermer au niveau de mes... Neuroport antérieur et neuroport postérieur, 26e, 28e jour, ça se ferme. Au même moment que j'ai la réintégration de mon cellulome externe dans un cellulome interne. Ces méninges, vous imaginez au départ, c'est juste emballé comme ça. Mais ça grandit. Et quand j'ai mon processus ici de télencephalisation, Et puis ça fait ça, et puis ça fait comme ça. Et là, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va former mon feuillet de mon système. Depuis, ça va rapprocher la ligne médiane ici, qui va former la cristagalie. Mes deux prosencéphales viennent se rapprocher le long de la ligne médiane. Et puis, ça va suivre tout le processus ici. J'ai un pli derrière au niveau qu'on a vu. C'était le pli postérieur qui va former ici, en arrière, ce qu'on appelle la tente du cervelet. Tu vois, derrière ici, c'est la tente du cervelet. Et là-haut, ça va former quoi ? Ça va former complètement tout ma faute du cerveau, qui est un processus de cérébralisation donné par la téléencéphalisation lors du redressement de l'embryon. Les membranes viennent suivre le

mouvement. Comme on avait vu que ça suivait les systèmes ventriculaires, là, ça va suivre le développement du cerveau et s'organiser. C'est de la durmère, ici, qui se développe. Et on voit que j'ai toute l'organisation. toute l'organisation Le compartiment de ma tente, de ma faute du cerveau, de ma tente du cervelet et de ma faute du cervelet qui suit. Là, ça se continue ici. Tu vois ce que je veux dire ? Nettons que je peux aller à l'intérieur, ça se continue tout autour de mon cerveau, ça l'emballe. C'est un emballage cadeau du cerveau avec, en fait, à un moment donné, une double couche. Une couche de type viscéral, qu'on appelle la durmère viscérale, et une couche de durmère pariétale. On va à un stade avant. Vous vous souvenez, tout au début, quand mon cerveau grandit, il est d'abord comme ça, ça se ferme et puis ça se plie. Au moment où ça se plie, ça va former d'abord trois vésicules. Et puis c'est juste avant le phénomène de téléencéphalisation. Donc si on veut faire le mouvement du cerveau, on avance, au départ, on fait les trois vésicules. Et puis téléencéphalisation, le grand redressement. Avant ça, vous avez cette flexion cervicale, etc. mais là le Mais là, le grand mouvement, c'est... J'avance comme ça, et puis je fais ça. Ok ? Je reviens et je me redépose à la base du crâne. C'est que ces vésicules cérébrales, On a vu déjà très vite que, extérieurement, cet ectoderme emballe complètement mon système nerveux. On est d'accord. Vous êtes à la maison ? Vous êtes à la maison ? Et ça, c'est du méso. Ce cerveau est complètement emballé par du méso. Donc, c'est complètement emballé, ça forme bien. Bien. Un tissu qui est tout à fait emballé. C'est l'emballage du cerveau. Ce sont des bonbons. Ici devant, puisqu'il va y avoir deux vésicules, il y a une espèce de gaine. Une densification dans le tissu. Et ici aussi, c'est une densification très forte. Mais c'est fort, c'est-à-dire que si je prends un tissu, et que je pourrais prendre, j'arrache tout et je le dépose comme ça, et qu'on voit un peu ce qui se passe, tu vois que là-dessus, c'est pas si plat, il y a des zones comme

ça qui sont très dures. C'est des gaines, qu'on appelle des ceintures dures. J'ai des ceintures dures antérieures, moyennes, postérieures ici. Avec ces densifications ici. Donc si je fais une coupe, le cerveau, de la dure-mère, il y a une couche qui est pariétale, et ici, viscérale, par rapport au cerveau. Et au-dessus, c'est toujours le même tissu mésodermique, mais avec des champs métaboliques qui auront changé, c'est-à-dire des changements de densité, de polymérisation, de liquide, etc., qui vont, à un moment donné ici, faire de le tissu qui est ici, c'est toujours du mésoderm, mais à un certain stade, ça va devenir de l'os. Et c'est dans ce tissu-ci que va se retrouver cette densification, tu vois, qui sera ici. On appelle les zones de gaines dures, qui sont très intéressantes et très importantes, qui sont retrouvées ici. Et l'ensemble de ces gaines dures, tu vois, ici, l'ensemble de ces gaines dures, c'est comme des anneaux, ce n'est pas dans le feuillet viscéral. J'ai repris ici, là maintenant, je vais rajouter encore un élément ici, qui sera le tissu osseux. OK ? Le oulalo, c'est trois anneaux, les deux sont là, comme ça, tu vois, et ils sont tous, tous orientés vers ma base du crâne. Que ce soit la dure-mère viscérale s'oriente, ils sont organisés vers cette base du crâne, qui est un lieu, qui est un lieu énorme sur un plan de tension membraneuse, intra-membraneuse, extra-membraneuse. On a vu que c'était une concentration de mésenchyme entre l'ectoderme et l'endoderme, entre le cœur et le vaisseau, et le cerveau, donc de notre façon, entre l'ecto et le méso, tu vois, à ce moment-là, qui organisait ce plan. on voit aussi toute l'importance de mon système veineux, qui s'oriente sur tous ces vaisseaux, qui se fait avec ce qu'on appelle quand même le sinus agital supérieur, inférieur, et cet énorme confluent, et qu'on regarde ça sur un autre plan, on voit que c'est une confluence de huit feuillets. Un, deux, trois, quatre, cinq, huit feuillets, dans lequel va arriver le sinus sagittal supérieur, le sinus sagittal inférieur, et les sinus transverses ici, qui vont se mettre ici. Les

ceintures sont ici. Elles seront surtout exprimées, dans la dernière pariétale, entre l'os et la dernière viscérale. Mais, c'est quand même, on la voit, elle est apparente depuis le système viscéral, pariétal et osseux, parce qu'ils s'interpellent. Mais c'est là où elles sont les plus exprimées, avec les anneaux, qui sont ici. Avec des densations, qui vont se faire, des densités là-dedans. Les chemines, un champ de rétention. rétention. C'est une partie du corps du sphénoïde et une partie occipitale et la base du crâne qu'elle a et mes processus pterygoïdes. Vous imaginez mon cerveau, il arrive tout doucement. Je ne suis pas encore au stade où j'ai la téléencephalisation. Je suis encore au stade où j'ai la première partie. Première partie, j'ai déjà la construction primaire, basique qui commence à se faire au niveau de ma base du crâne. C'est déjà la rencontre entre mon cerveau antérieur et mon cerveau postérieur qui comprime et qui forme cette base du crâne. On est à ce stade-là. Et donc j'ai un ligament qu'on appelle le futur ligament interorbicularis, devant, qui est là. Et au moment où tout d'un coup mon processus de téléencephalisation se fait, tout d'un coup, tout le système est tiré vers le haut, tu vois. Et mes pterygoïdes qui sont là font... Elles sont redressées et je pars ici et j'ai tout mon processus de la fausse du cerveau qui se développe là-dedans en même temps. Et au même moment, j'ai le rapprochement de mes pterygoïdes ici. Au même moment, un tissu endodermique qui, lui, va subir un champ par le redressement, le rapprochement de mes pterygoïdes au moment où j'ai les pterygoïdes. L'éloignement de mon encéphale vers l'arrière, c'est-à-dire qu'il devient téléencephalique, il tire tout le système vers le centre. tu vois, qu'est-ce qui se passe j'ai ici le tissu qui commence à se plier ici, tu vois ça fait ça et ce tissu qui commence à se plier ça forme ce qu'on appelle les Kohan t'as déjà vu les Kohan, elles sont mises comme ça tu vois, au départ c'était un tissu qui était là et dans la phase du redressement mes petits rigouilles sont tirées vers ici et là

vient se former ma Christagalie qui fait partie du processus de cérébralisation la Christagalie c'est un lieu très important pour le corps, pour l'esprit la croix du galéen c'est là où on vient baptiser c'est là où on fait la croix c'est un lieu d'initiation parce que c'est un lieu où tu ouvres, tu rapproches et tu fais ton unité avec tout ton système antérieur tu fais toute ta cérébralisation tu fais toute ta face qui commence à se recruter tu as tous les rééquilibres de tes yeux qui s'orientent à ce moment là en même temps que ça devient un point d'appui pour toi et là tu commences à voir tu vois, à voir ce qu'on appelle la clairvoyance ça c'est la voyance puis tu as la clairvoyance puis après tu auras la polyvoyance c'est à dire que tu vois Dieu dans chaque chose la clairvoyance c'est que tu commences à voir le discernement des phénomènes la voyance c'est que tu veux jouer sur l'émotion qui est autour de toi ce processus-ci il se fait au même moment le vésicule qui était pro-encéphalique devient télé-encéphalique et se développe tellement qu'il commence à former ce qu'on appelle le processus d'hémisphérisation dans ce processus il y a une force qui était d'abord une force descendante tu vois c'était la force de flexion de l'embryon et là tout d'un coup c'est une force de redressement de l'embryon qui fait comme ceci tu vois donc c'est une force de redressement dans ce moment de redressement j'ai mes deux hémisphères ça grandit Grandi ! et puis ça fait ça Et là, ça fait ma faute du cerveau. Et là, ça vient s'attacher sur quoi ? Ça vient s'attacher sur la zone ici, qu'on appelle la Christagalie. Tu vois ? Qui vient se serrer pour aller jusqu'à Egnon. On se développe de Nazion jusqu'à Egnon. Et de Egnon jusqu'à Astéryon. Chaque pas va libérer Astéryon. Chaque fois que tu marches, l'Astragale, le Calcaneum, il y a une raie de Nantes qui monte jusqu'ici. Si ce n'est pas libre, ça ne marche pas. La police... Même chose, si tu n'as pas une bonne occlusion, si tu n'as pas la structure coronale qui est libre, tu ne peux pas avoir une liberté d'action au niveau de tes zones du crâne.

C'est pour ça qu'il faut libérer le frontal et la zone ici pour avoir une liberté ici. Ça veut dire que si ce n'est pas libre ici, tu peux parfois avoir juste... Une petite dent, on peut manipuler une dent. Moi j'ai un copain, il arrive à libérer une zone ici, sur tout simplement une petite dent de ta structure ici. Non, non, non, non, l'os se construit dans la membrane. C'est ce que j'ai dessiné ici. C'est le cerveau, comme j'ai essayé de vous expliquer, qui est le moteur pour le développement. Mais autour, dans la création déjà de mon tube neural, on a vu qu'il y avait un tissu mésodermique qui apparaissait. Et j'ai dit, tiens, au départ, si on voit, c'est tout du mésoderme. Tout du mésoderme. Seulement, ce mésoderme va se densifier. Donc, une partie qui sera tout proche du cerveau sera la durmère viscérale. Puis, ça va devenir la durmère pariétale. Et au-dessus, c'est de l'os du mésoderme, au départ, qui en fait subit les champs métaboliques de croissance et d'expansion et commence à se durcir tout autour pour former ce qu'on va appeler la voûte. Mais ça, je vais réexpliquer encore. Donc, au départ, c'est un même tissu. C'est pour ça que quand... Quand on fait une perception du crâne, on peut passer facilement dans ces structures-là parce que c'est un même fluide. C'est une même fréquence, en fait, qui est légèrement modifiée en alpha, bêta et theta. C'est une image. Donc, la question, c'est que l'os, il est la résultante du système. C'est ça que je veux expliquer. L'os est la finalité du processus. Au moment du processus d'ascensus, donc de la cérébralisation, donc je cerveau comme ça, et puis à un moment donné, on voit que ce cerveau grandit très très fort. on voit tu vois, il fait comme ceci, et il tient vers le haut, ok ? Eh bien, on va voir que ça va donner un rapprochement sur la ligne médiane de toutes les structures, mais en même temps une itération par ici et par ici. Donc c'est cette force ascendante et descendante qui ramène le matériel latéral vers le centre, ok ? Mais dans ce mouvement-là, tu vas voir que le tube digestif primitif qui est orienté comme ceci, va avoir un

mouvement vers le haut, comme ceci. Il est comme ça, et là la croissance se fait, et lui il fait ça. Et c'est dans ce processus que la langue suit sa force de développement. C'est pour ça qu'on dit que la profondeur de la langue est le reflet de la profondeur de la cérébralisation. c'est une symétrie homologique on voit que cette base du crâne devient vraiment un point de convergence un point de rencontre d'informations qu'elle soit d'abord purement osseuse avec les cartilages hypophysaires et par accordage qu'elle soit déjà sur le plan endodermique et ectodermique et puis toutes les membranes de tension du cerveau et on verra même que on pourra même rajouter les lignes en rapport avec les arcs bronchiaux viennent aussi s'insérer sur cette base du crâne par thylaphyrine. C'est vraiment un point de convergence d'informations de dingue où on voit rien que sur un plan déjà hypothalamo-hypophysaire via les noyaux supraoptiques ou paraoptiques Envoie ! tu vois de l'information de la chimie du tonus du corps, de toute l'information donc l'acide basique de toute l'information. Vous avez un toit, le toit de l'hypophyse, qui est un toit vasculaire. C'est rempli de petits vaisseaux, là. On voit, tu vois, que ces gains durs primitifs s'orientent, s'organisent sur cet axis. C'est là où on se rend compte, tu vois, comme en Bechmin, les cages dessinées, ces lignes de force qui se rencontrent vers cette base du crâne, on voit bien l'orientation, cette chose-là, avec un confluent très important. qu'un con... Sur un plan V2, tu vas se retrouver au niveau de l'union. Rencontre de force, rencontre de moments importants. On revoit encore une autre façon de voir ces images, où on voit la faux du cerveau, les gaines dures et l'os qui va se construire, mais qui au départ sont formés d'un tissu commun. C'est simplement le développement, le grand moteur c'est qui pour tout ça ? C'est surtout le développement du cerveau, c'est lui qui organise ça. La croissance de ce cerveau, ce processus de céphalisation, c'est ça qui organise tout ça. C'est pour ça que mon point de repère que j'ai commencé

hier, je vous ai dit ok on va commencer avec ce processus de développement du cerveau, tout simple, et là je suis occupé à rajouter plein d'éléments autour. Tu as tout le système ventriculaire, toutes les membranes de tension, toutes les gaines dures, tout l'os. finalement vient se construire autour la seule chose qu'il faut retenir pour le moment c'est le tai chi du cerveau et dans le tai chi du cerveau vous pouvez rajouter ok on va faire ça ensemble je suis là j'ai le tai chi, on fait le mouvement en avant, j'ai le mouvement de télécephalisation on retient ça ça fait ça et ça fait ça intérieurement qu'est-ce que j'ai ? ok je peux dessiner mes ventricules j'ai l'image de mes ventricules dans ce mouvement à l'extérieur je fais ça je fais ça maintenant, hop j'ai toute ma membrane, j'ai ma peau du cerveau qui se construit derrière vous vous souvenez il y avait le pontine qui se faisait derrière, ça faisait la tente du cerveau Je t'ai appelé. je l'ai dans le mouvement comme ça le cerveau qui se développe avec ces gaines qui vont se répercuter ici. On voit bien, tu vois, comme tout s'organise, on voit bien ici les lignes de force, ces gaines dures à l'intérieur, tu vois, c'est l'importance, tu vois, de cette durmère, la moelle épinière qui est ici, la vertèbre, et on voit bien ici, regardez, je prends la pimeire qui est vraiment ici, je prends l'espace suparagnoïdal, l'arachnoïde, et on voit ici la durmère interne. Tu vois qu'elle est là ? Et puis la durmère externe qui fait partie de la densation osseuse. En fait, on peut remonter ça partout. Alors, vous avez aussi une chose qui sera importante, c'est que quand on étudie le développement sur le plan d'un air, tu vois, en fait, il y a une espèce de continuité, on va dire symbolique pour le moment, qui est une espèce de continuité entre ma durmère externe et interne, si tu veux ici, mon arachnoïde et ma pimaire sur la coupe ici, où j'aurai l'épinèvre qui serait l'épinèvre ici externe, durmère externe, durmère interne, c'est une espèce de continuité, le périnèvre ici, tu vois, qui serait en rapport avec l'arachnoïde, et l'endonèvre qui sera en rapport avec la continuité au

niveau de la primaire. Mais ça c'est un point d'interrogation. Par contre, ce qui est vraiment important de se rendre compte, c'est ces petits vaisseaux qui se retrouvent, qui sont des vaisseaux mésodermiques, dans l'endonèvre ici, entre autres, et que c'est ça, ces petits capillaires sanguins, qui peuvent provoquer en fait des stasques, c'est eux qui nous embêtent, c'est pour ça que en travaillant les pompages, en travaillant les libérations, c'est comme ça qu'on redéconectionne en fait les problèmes radiculaires. Parce que vous avez en fait ce qu'on appelle ici, si je vais un peu plus loin, avec les ligaments de Hoffman et le percule de Forestier et tout. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un truc qui se développe ici. et qui crée une espèce de petite soupape, comme celle-là. Et en fait, ça se continue avec cette durmère aussi, tu vois, qui crée une espèce de soupape de protection, qui fait qu'en fait, tout le système durmérien, tu vois, et ça c'est important, pour former le corps lisse. Le manchon durmérien, crânio-sacré, mais en fait, le manchon durmérien, crânio-sacré, vertébral, est dans l'idée, ce serait presque un manchon crânio-sacré vertébro-périphérique. C'est-à-dire que tout l'axe durmérien, non seulement il est inséré ici, avant on pensait que ça flottait un peu. Et puis on s'est rendu compte que non, et en fait c'est soutenu même par des systèmes durmériens, et même par des opércules, ici important, qu'on appelle les opércules de Forestier, qui tiennent une soupape, qui maintiennent, qui permettent un équilibre hydrique. Un équilibre hydrique dans les... dans le sens qu'il n'y ait pas de phase de congestion, si tu as des congestions, c'est la merde au niveau de ton... de tes racines nerveuses, tu vois, c'est une protection. La voûte, par rapport à ça, tu vois, ça c'est déjà de l'identification, mais il y a encore une zone ici, tu vois. Alors regardez bien ici, tu vois, on voit toutes ces membranes-là. et bien ça c'est une, en fait c'est encore des gaines, tu vois, on le voit ici, ça c'est les différents champs métaboliques de densation, de distusion qui participent à la synchondrose de la base

du crâne, mais ce qui est important là c'est au niveau de la route, c'est la détraction qui va former les os dans le sens des déplacements qu'on voit ici, tu vois, avec les déplacements des trabécules et des ostéoblastes qui vont former les plaques osseuses frontales, tu vois, et on va voir les noyaux d'ossification qui se forment à leur périphérie ici sur le côté et ici, tu vois. Je fais une image d'un cerveau. C'est en phase de développement comme ceci, tu vois, un encéphale, avec, on avait vu que ça se construisait, d'abord, on va reprendre ici, et on va imaginer qu'il y a ces gaines dures autour, tu vois, et ces gaines dures, ça fait des espèces de fenêtres, comme ceci, tu vois, j'ai une fenêtre. Puis j'ai une autre fenêtre ici, puis j'ai une autre fenêtre comme ça, tu vois. Puis j'en aurai encore une ici, comme ça. Alors, vous allez presque pouvoir me dire dans la chronologie d'apparition de la densification des os du crâne, en suivant simplement le cerveau, on se développe, on va d'abord avoir l'os frontal, qui va se densifier. Donc, lui derrière, ça va être le pariétal, puis l'occipital, la partie supérieure, tu vois, parce qu'il ne fait pas partie de la base, c'est différent, et pour venir, la partie supérieure au niveau temporal. Et en fait, j'ai simplement, dans cette phase, la force de développement, tout à fait, bien précise, de développement de mon cerveau. D'abord, vous avez l'os qui était ici, qui était d'abord membraneux, va, par ce processus de changement métabolique, créer un os qui va devenir dû. Mais il y a certaines fenêtres ici, tu vois, ici, il y a des fenêtres qui restent, tu vois, qui étaient liées à ces bandes, qui sont là, comme ceci, et là, comme ceci, ici. Et c'est là-dedans, dans cette zone-ci, que va s'ossifier, depuis le centre, par ces centres, ce sont des centres membraneux, tu vois, va s'ossifier là. Membre à noeud. Puis il va se suffire d'eux pariétal, puis d'eux. Je vous remercie. ça ne fait que suivre le développement de la céphalisation. C'est le même processus. Donc de l'intérieur vers la périphérie, je peux dire que je vais avoir à l'intérieur le système ventriculaire, à l'extérieur le système

diomérien avec toute l'organisation en cloisonnement, et tout à fait à l'extérieur, le résultat sera la mise en place du frontal, du pariétal, de l'occipital et de la partie supérieure au niveau temporal. Et en fait, si on regarde... Ces gaines dures, on les retrouve ici, simplement, sous bande de lignes de force ici. Quelle gaine dures principale je vais avoir ici ? C'est ma faute du cerveau. Une forme de gaine dures, en fait, très antérieure. Et là, on voit bien les fenêtres, tu vois. Et là, on voit bien l'effet. la fenêtre frontale, la fenêtre pariétale et la fenêtre occipitale. Et qu'est-ce que c'est ici ? Eh bien, ça va être les sutures, les futures sutures. Voilà, et là on voit, tu vois qu'au départ, c'est simplement, Voilà, et là on voit... on voit bien ici les fontanelles qui sont simplement en fait des mouvements et on voit tout le mouvement ici, tu vois, comme ceci, c'est fait. Et on voit... Il y a deux phénomènes qui sont importants, les phénomènes piezoélectriques, ces forces comme ça va se plier au niveau de la face, au niveau des dents, au niveau des choses, c'est des choses qui vont rentrer profondément dans le tissu, on en parlera dans la face. Par contre, une chose qui est importante, c'est que la corticale endocrinienne elles, elles vont subir principalement des effets provenant de l'expansion cérébrale et des aponevroses méningées. Tandis que les corticales exocraniennes, exocraniennes, subissent principalement ceux des muscles cervicaux, donc de la posture céphalique et mandicatrice, c'est-à-dire de tout le massif lingua et les masticateurs. Alors ce qui se passe, c'est que la corticale endocrinienne, elle, elle va subir, c'est elle qui subit tout. le mouvement interne venant de l'intérieur vers l'extérieur mais à un moment donné au moment où le fœtus à un moment donné il commence à bouger déjà il commence à à succion déjà très tôt en fait c'est à dire vers 5-6 mois on voit vraiment que ça bouge clair et net quoi tu vois et en fait tu les vois vraiment et en fait à ce moment là c'est la corticale exocranienne pourquoi parce que c'est les muscles derrière qui commencent à tirer

alors tout au début quand tu regardes un crâne tu vois ici d'un fœtus qui a 3-4 mois la différence ici c'est que ça c'est surtout le cerveau qui a grandi qui fait le mouvement tu vois comme ça mais là maintenant l'allongement postérieur au début de la période fœtale où les muscles sont peu actifs l'expansion cérébrale particulièrement dynamique la boîte crânienne est sphérique tu vois assez sphérique tandis qu'à la fin de la période fœtale c'est à dire au début du 7ème mois tu vas te retrouver jusqu'à la naissance où les muscles cervicaux et faciaux deviennent actifs et le crâne prend une forme beaucoup plus transversale et allongée c'est une clé thérapeutique pour nous montrer qu'il existe cette fois-ci un équilibre entre une force extérieure et une force intérieure par rapport au système et ça veut dire que lorsqu'on a des enfants qui ont une plagiocéphalie par exemple on doit être attentif à la force extérieure aussi c'est à dire au positionnement c'est à dire à faire travailler ces muscles cervicaux à les remettre dans une dynamique et à ne pas faire que du crânien qui a été justement un gros problème chez les ostéopathes qui n'avaient pas compris ce niveau-là et qui ne faisaient que du crânien. On disait non, ça va s'arranger, mais non, ça ne va pas s'arranger du tout. Tout l'angle des classes 1, classe 2, classe 3 qui va s'exprimer déjà avec l'angle sphénoïdal et les angles des rochers pour montrer avec le redressement de la courbure céphalique qui fait que c'est ça qui va nous donner un rétrognathe, un prognathe ou un normognathe. On voit bien, 28 mois, comment ça commence vraiment à s'allonger vers la postérieure, l'importance de cette activité externe. Différentes fenêtres, au départ plutôt sphériques, puis à la fin ce sera beaucoup plus transversal. C'est une espèce de continuité, tu imagines tout ce drainage ici est complètement en continuité. J'ai eu tout ce drainage. Avec tout le drainage vertébral. depuis le petit bassin jusqu'ici. C'est pour ça que les cancers de la prostate, etc., ou d'autres, chez les femmes utérines, peuvent donner des cancers, en fait, cérébraux.

Cette continuité qui se passe, il y a des continuités vasculaires. Ça, c'est assez intéressant de l'étudier lorsqu'on étudie le système vasculaire en détail. On a une clé thérapeutique qui est quand même ce sinus ici. C'est une congestion au niveau de ces rapports sur la partie inférieure du sphénoïde, au niveau de mes ptérigoïdes, où il y a une congestion veineuse qui est très fort liée à toutes les membranes de tension, à tout l'équilibre mendicatrice, que ce soit lingual ou temporal ou purement maxillaire, qui va se répercuter là. Quelqu'un qui vient avec un torticollier aigu, c'est une stase. Il est figé dans son truc. Il y a une contraction, il faut libérer la stase. Moi, je travaille par exemple ce point-là pour relibérer, décongestionner le système. Même chose jusque dans le petit bassin. Ça permet de redégager puisqu'il y a une continuité sur tout le sinus. Quand on a un lombago aigu, quand on a des choses comme ça, il faut aussi penser veineux. La voûte, elle est essentiellement d'origine membraneuse, tandis que la base est essentiellement d'origine cartilagineuse. Avec l'occipital. Qui, lui, pour la partie supérieure, est membraneuse, tandis que la partie basis-occipital est cartilagineuse. On l'avait vu déjà dans le premier champ de construction. Qui est la grande aile du sphénoïde, qui est plutôt d'origine membraneuse. Le frontal, sauf l'épine, et les pariétaux, qui sont membraneux. Tandis que tout le reste, une grande partie de... pratiquement tout le temporal, l'aile moelle, le sphénoïde et l'épine frontale, sont d'origine cartilagineuse. Le mouvement du champ métabolique est différent. La partie qui est complètement... qui est d'origine membraneuse, avec la partie qui est d'origine cartilagineuse. Au départ, c'est un même tissu, mais qui suit des champs métaboliques différents. Un en détraction, l'autre en compression. Entre le tact, l'équilibre, le goût, le naturel, l'odorat, l'audition et la vision, on voit que l'odorat, en fait, se retrouve très très tôt. C'est lui qui gagne avec le tact. Le toucher et l'odorat, c'est très précoce dans notre capacité d'intégration nationale. La grande aile à

l'esprit sphénoïdal, tu vois, c'est seulement à 22 ans, vraiment, que ça commence. Mais que, en fait, si on regarde, tu vois, regardez, ça se termine ici. On commence à s'ossifier jusqu'à 89. À 81 ans, tu ne fais plus bouger de choses. tu vois en fait c'est noté la synostose tardive des structures de l'ensemble occipitotemporale après la naissance la croissance et la maturité sont encore très importantes pourquoi ? parce qu'après la naissance on constate par exemple que le cerveau a encore une croissance volumétrique qui double entre sa naissance et 6 mois donc le cerveau il va encore grandir donc la corticale endocrinienne va encore subir des modifications jusque dans la corticale l'exocrinienne via les informations qu'elle reçoit quand même de l'endo va doubler entre la naissance et 6 mois, ça veut dire que toutes les plages de céphalie on doit les traiter avant 6 mois c'est ça qu'il faut se dire au début tu les vois et tu te dis tout va bien et puis tout d'un coup crois moi en l'air ça va pas du tout le travail d'ostéopathie on fait un travail actif à partir du système endocrinien de libération des membranes du travail de tous ces membranes endocrinien mais aussi viscéral puisque tout sera lié parce que là on peut aller un petit pas plus loin ça se synchronise avec le système viscéral sur les plans membraneux La faute du cerveau sera en relation avec le développement de la fausse hépatite. Le mésodiodénome se mettra en même relation que la tente du cervelet et le méso-sigmoïdien se mettra en même mouvement que le développement de la fausse du cervelet. À six mois... Le mastic sera déjà un peu dur, il y aura effectivement l'épaississement du derme, la molérisation, la mastication qui sera plus importante, qui va un peu camoufler le truc, mais il restera peut-être des densités mal exprimées. Classiquement, il n'y a plus d'augmentation de croissance cérébrale après 5 ans. L'augmentation faible du périmètre, c'est dipolisation, pneumatisation, pneumatisation, augmentation du volume, épaississement du derme, pneumatisation c'est

important, vers 3-4 ans, vous avez le sinus maxillaire qui devient vraiment, il doit s'ouvrir, ça se fait en même temps que les fonctions des surrénales qui deviennent complètement actifs, ça fait des enfants, ce qu'on appelle les petits morveux. Ils ont le nez qui coule tout le temps, et en fait ils sont hyper, ils sont bloqués là, Mais en fait, ils ont eu... et ils ont le nez qui coule. Les gens qui viennent maintenant, qui ont... qui ont 30 ans, 40 ans, qui font des sinusites à répétition, il faut aller voir ce qui s'est passé parfois dans cet âge-là. C'est comme ça que je le fais, je viens voir, je regarde, et puis je vais poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu ? Est-ce qu'on va aller voir là-bas ? Tiens, peut-être que j'ai passé un événement où j'étais bloqué. On va essayer de voir la mémoire qui était là, et peut-être l'affaire, s'il y a eu un traumatisme qui n'a pas été exprimé, et si c'est continu, c'est exprimé. Puis, vers 7 ans, tu as la fonction des sinus frontaux, en même temps que l'espace thyroïdien. C'est là où je dis, vers 7 ans, on commence à faire front. Avant ça, on est dans la bagarre, et puis à un moment donné, non, maintenant je commence à avoir la raison, je peux parler, je peux faire front à l'autre, par ma parole, parce que je commence à avoir les mots qui sont donnés et électrifiés, si tu veux. Et puis, vers 10-12 ans, tu as la fonction hypophysaire qui apparaît, C'est pareil, on m'a... en même temps que les sinus phénoïdaux et mastoïdiens. sphénoïdaux et mastoïdiens, et ça c'est un moment où, vous allez bien comprendre, c'est le cerveau qui tombe dans les testicules. Tu commences à tout le temps penser par ta queue. C'est là où il faut aller voir ce qui se passe dans les sinus sphénoïdaux, C'est là où il fallait voir. dans les sinusites mastoïdiennes, tu retrouves ces niveaux-là, Tu retrouves... tu as des gens qui restent bloqués là-dedans. On s'est rendu compte que depuis les années 80, on a commencé à mettre les enfants, en tout cas en Belgique, je pense en France aussi, on met tous les enfants sur le dos. Papa, c'est dans le mobile. Non, c'est le suivi d'une émission. On

subit d'une autre façon. Et en fait, il y a moins de risques, soi-disant, d'étouffement. Par contre, on a constaté dans un premier temps une augmentation énorme de laugement de céphalie. C'est-à-dire que les enfants, ils étaient toujours couchés d'un côté, et en fait, tu vois, les plages de céphalie ici, et en fait, l'enfant est comme un ballon de baudruche, puisque le crâne, il va doubler de volume, et bien, on va se développer là où on peut. Ça, c'est une position, tu vois, intra-éthérine, où l'enfant, on voit déjà qu'il est bien tordu, quoi. Tu vois, s'il reste comme ça jusqu'au bout, c'est une descente, presque d'image, mais dans l'autre sens. C'est un enfant qui est déjà en position basse au niveau étherin. Normalement, l'enfant devrait être mis, tu vois, dans cette position-là. Normalement, dans la logique, c'est une présentation occipitopubienne. Occipitopubienne, c'est ça ? Qui est une grande majorité, mais qui peut avoir des frontopubiens. Mais dans la présentation occipitopubienne, au moment où on fait une présentation, où on fait le mouvement, c'est l'étherus, et c'est tout ça qui guide le bazar, il y a des étapes dans lesquelles on doit aller respecter. Alors, ce qui se passe aussi, on a une étude qui a montré maintenant que dans l'acquisition des informations... de la progression de l'approche psychomotrice de l'enfant, depuis qu'on met les enfants sur le dos, ils ont créé en fait plus vite un développement des mains, tu vois. Quand est-ce qu'apparaissent les premières dents ? Entre 7, 6, 7, 8, 9 mois. Entre 7 et 10. L'enfant, il commence à se redresser là. Ça, c'est l'idéal. Ces premières étapes-ci sont vraiment importantes. Que l'enfant puisse faire son roulement tout seul, et surtout cette position-là, tu vois. Sous-titrage ST' 501 Ce passage-là. Et puis il va avoir cette position massiviste. Et très souvent on passe de là à là.